

El Renacer del Movimiento: Guía Definitiva de Entrenamiento Posparto

Basado en la evidencia científica 2025 para una recuperación segura, fuerte y consciente.



Presentado por Lumen Movimiento

El Posparto como Ventana de Oportunidad

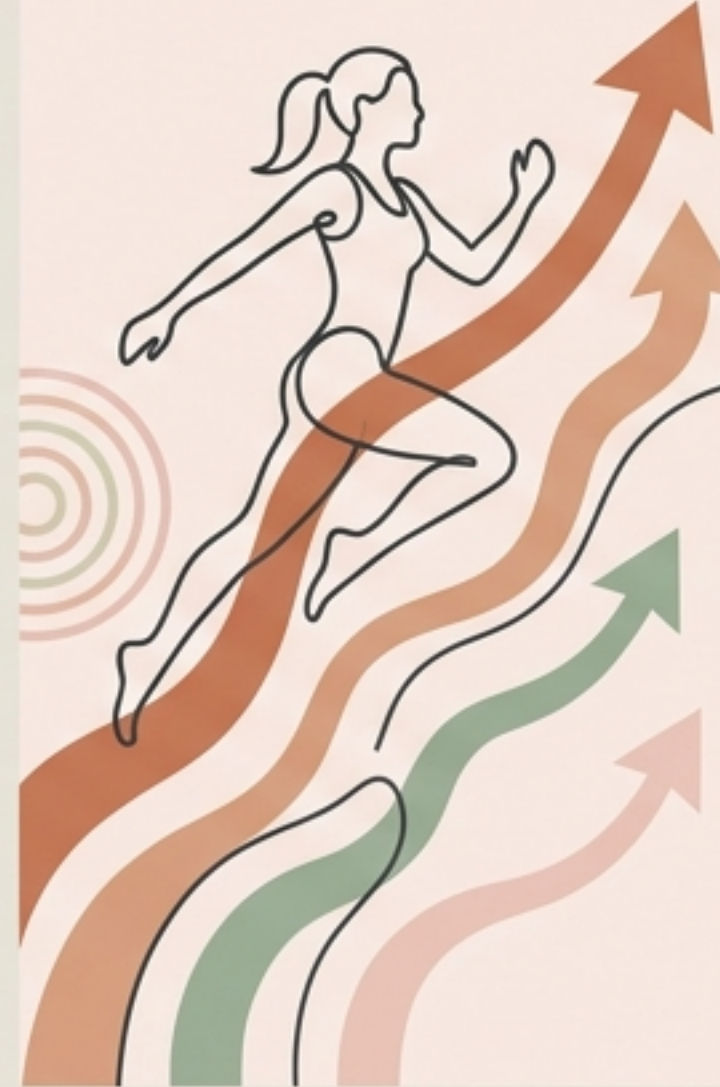
Históricamente, el puerperio ha sido tratado como una fase pasiva. Hoy sabemos que el comportamiento físico en esta etapa dicta la trayectoria metabólica y musculoesquelética de la mujer a largo plazo.

El Paradigma Tradicional



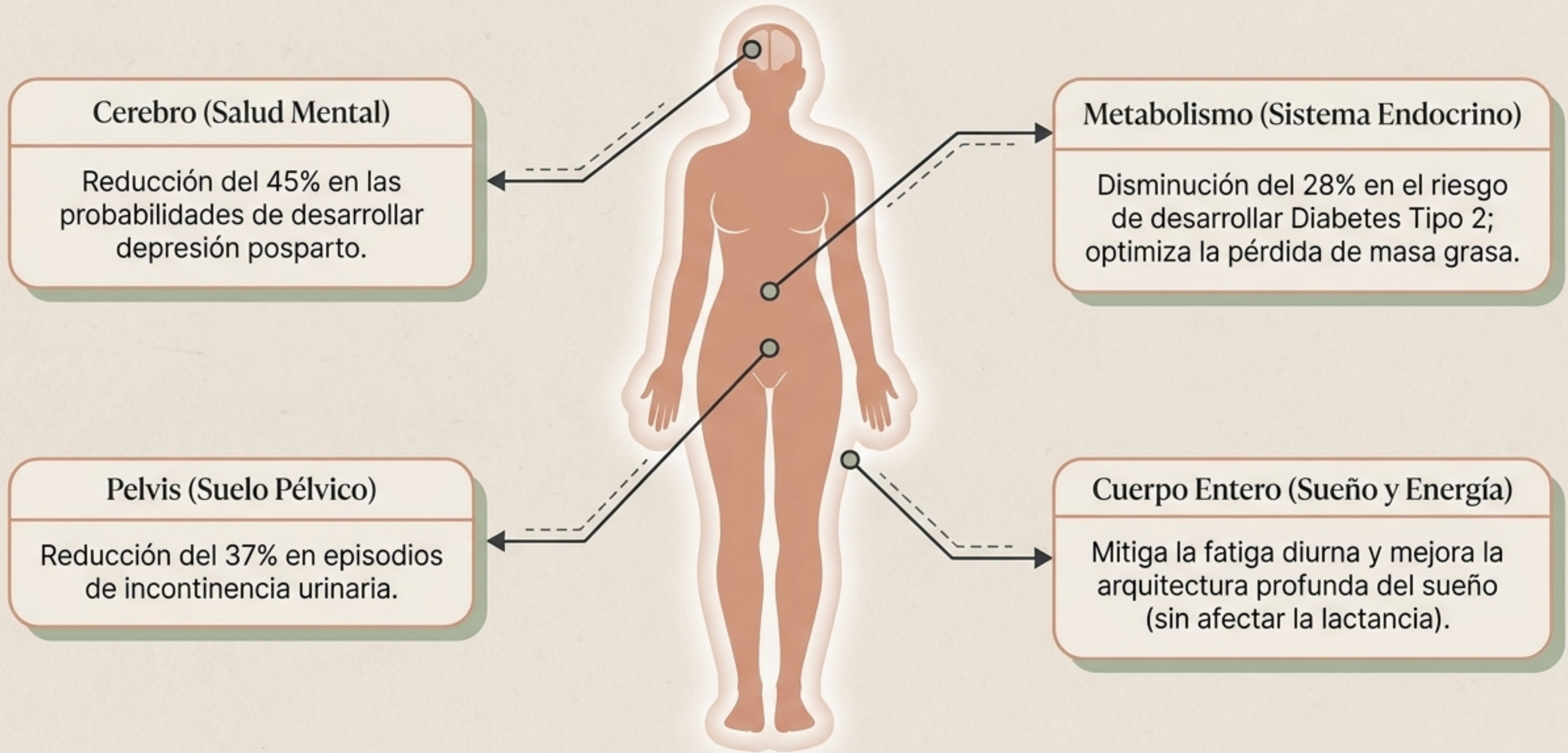
- Reposo prolongado e inactividad física.
- Miedo al movimiento.
- Foco exclusivo en el bebé; la madre queda desinformada (solo el 22% recibe consejo sobre ejercicio posparto).
- Resultado: Hábitos sedentarios que persisten durante décadas.

El Nuevo Paradigma 2025



- Recuperación activa y movilización precoz.
- Progresión individualizada y basada en síntomas.
- Intervención directa sobre la salud física y mental de la madre.
- Resultado: Prevención de enfermedades crónicas y restauración funcional completa.

Los Beneficios Integrales del Movimiento



Seguridad Primero: El Filtro de Preparación

Basado en el "Get Active Questionnaire for Postpartum" (2025).



La “Dieta” de Movimiento Posparto

Las directrices globales 2025 prescriben una dosis específica para maximizar tu recuperación.

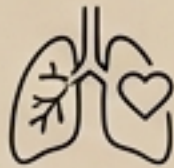


La Línea de Tiempo de Recuperación

Fase 1 (Semanas 0-2)

Respiración y Conexión

Caminatas suaves, ejercicios de Kegel precoces, respiración diafragmática. Foco en la curación tisular.



Fase 2 (Semanas 2-6)

Activación Base

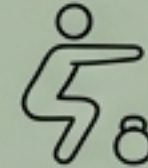
Aumento del tiempo de caminata, contracciones isométricas, puentes de glúteo ligeros.



Fase 3 (Semanas 6-12)

Fuerza Funcional

Ciclismo indoor, natación, sentadillas, peso muerto ligero (cargas <15kg o el peso del bebé).



Fase 4 (Semana 12+)

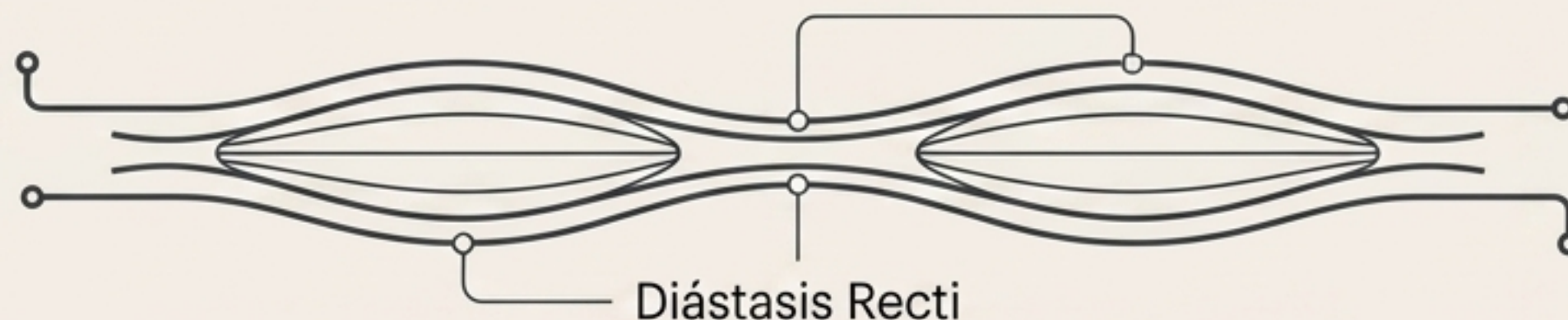
Retorno al Impacto

Preparación para correr, saltos controlados, fuerza unilateral (requiere superar el test de impacto).



Foco en el Centro: El Mito de la Diástasis (DRA)

La ciencia actual desmiente las reglas tradicionales sobre el entrenamiento abdominal.



Mito / Práctica Desactualizada



Maniobra de Aspiración

Se creía que era la única forma segura, pero la ecografía muestra que tracciona lateralmente la fascia y **ensancha** la separación.

Realidad Clínica

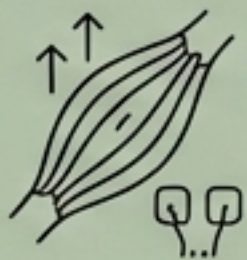
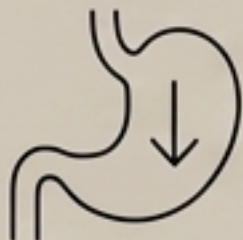


Crunch Controlado

Lejos de estar prohibido, la contracción de los rectos anteriores **reduce** inmediatamente la distancia inter-rectos. El enfoque moderno es multimodal.

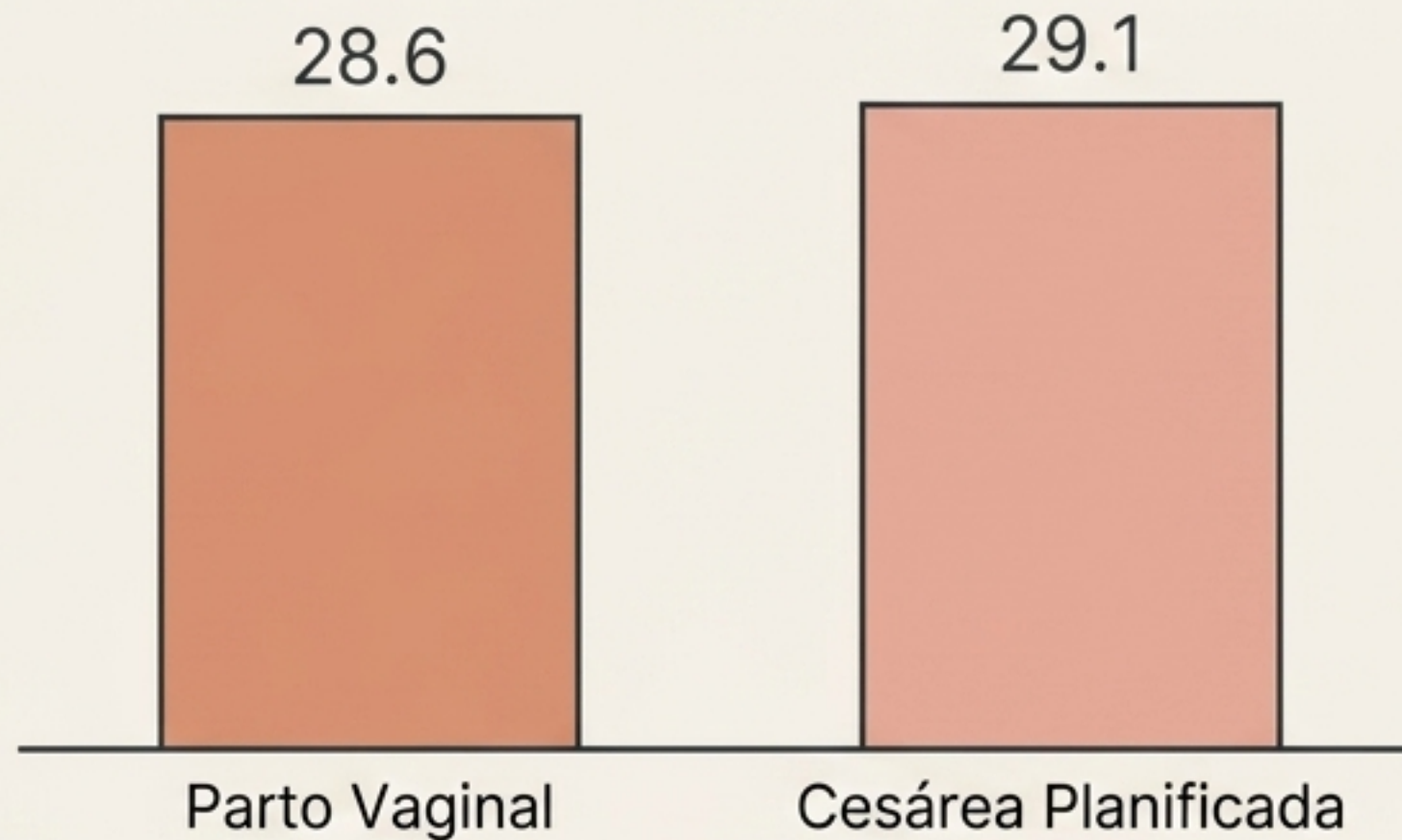
Matriz de Eficacia: Rehabilitación Abdominal

Qué funciona (y qué no) para cerrar la diástasis, según meta-análisis de 2025.

	Tratamiento	Details	Resultado
Alta Eficacia (Score >0.90) 	Entrenamiento Multimodal (ETMC)	Entrenamiento profundo + superficial (Pilates) combinado con Electroestimulación y Biofeedback.	Resultado: Reducción de hasta -26mm.
Eficacia Moderada (Score 0.52) 	Soporte Pasivo (Fajas/Vendajes)	Vendaje neuromuscular o fajas.	Resultado: Aproximación pasiva y transitoria; no genera fuerza real ni adaptación a largo plazo.
Ineficaz / No Significativo 	Aspiración Aislada	Hundir el abdomen sin trabajo superficial.	Resultado: Ineficaz por sí solo; riesgo de ensanchamiento superior.

La Base del Movimiento: El Suelo Pélvico

¿La cesárea protege tu suelo pélvico a largo plazo? La respuesta clínica es NO.



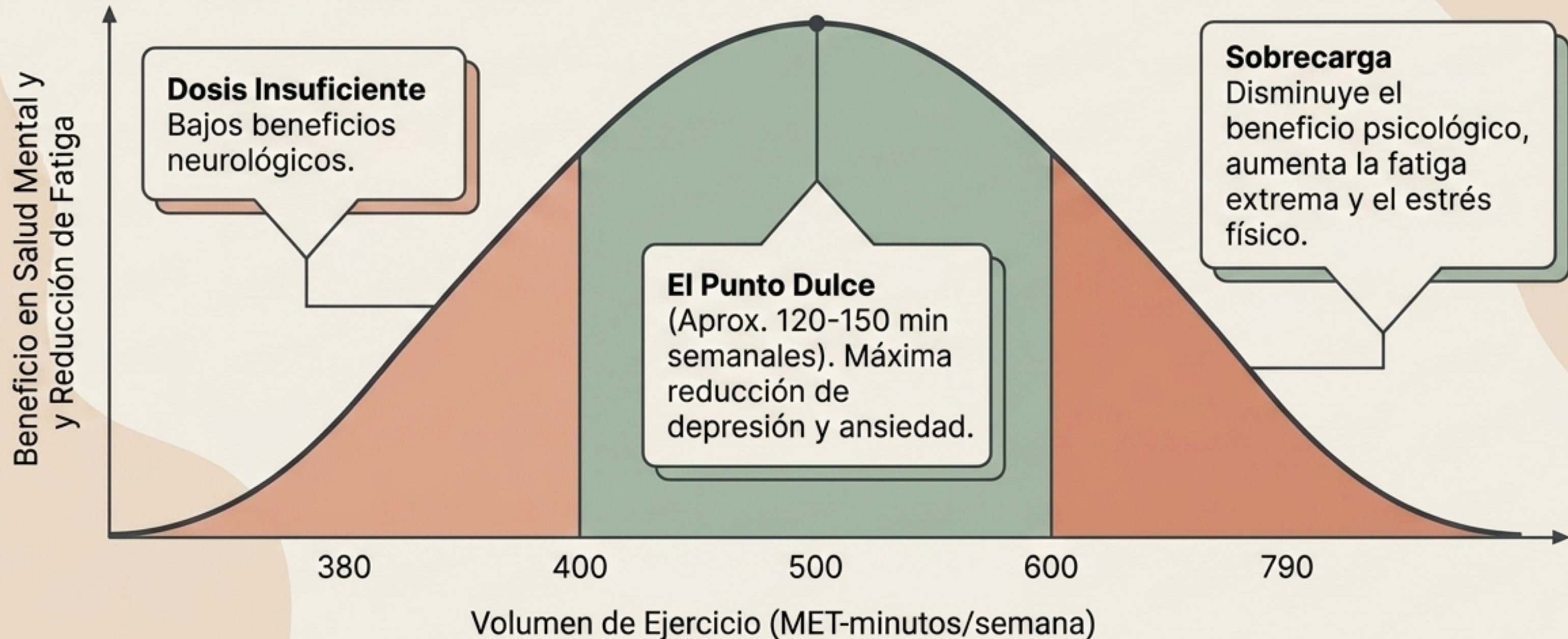
Visual Insight Callout:

La debilidad pélvica es causada por la sobrecarga mecánica y hormonal de las 40 semanas de embarazo, no solo por la vía de parto.

Objetivo Clínico: Alcanzar un Grado 3+ en la **Escala de Oxford** antes de volver a levantar cargas pesadas o correr.

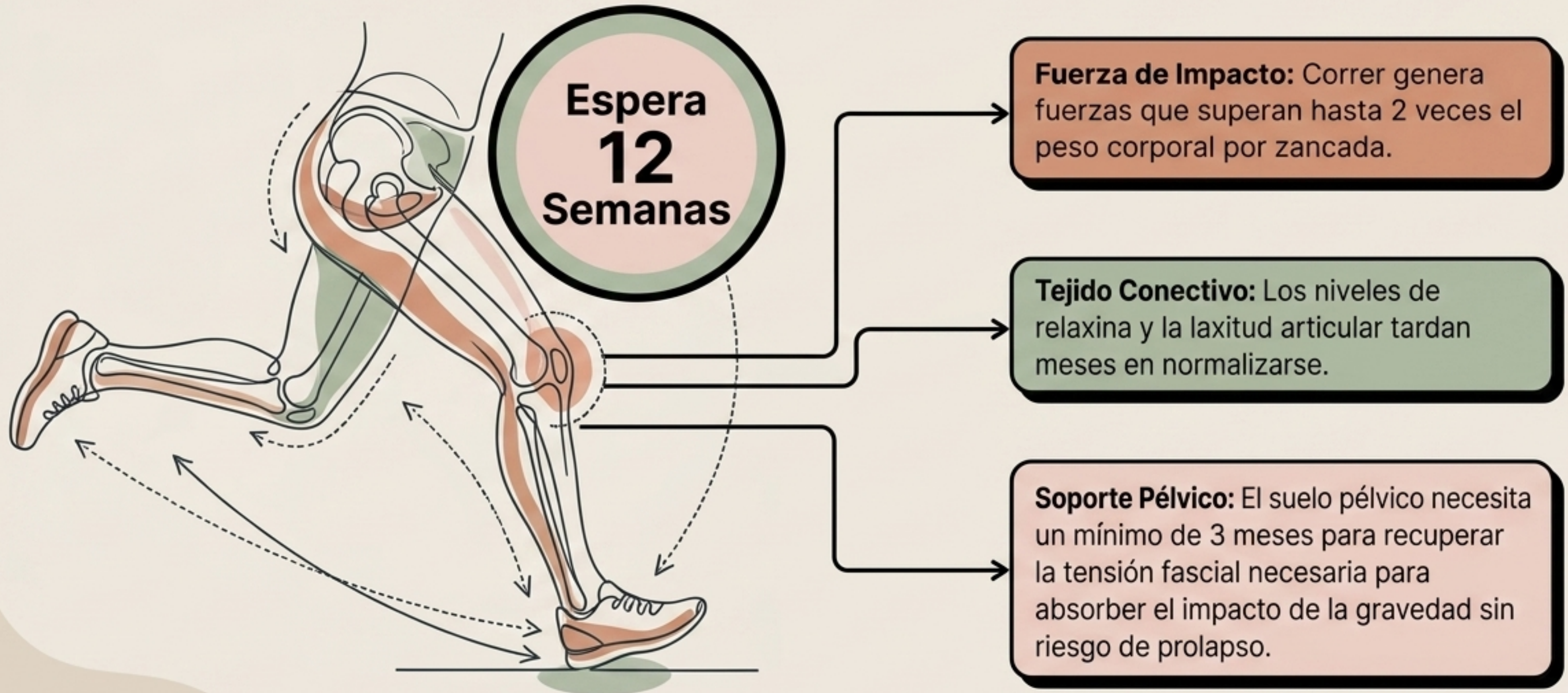
Fatiga y Salud Mental: Encontrando el 'Punto Dulce'

Más no siempre es mejor. Cómo optimizar la dosis de ejercicio para vencer la depresión posparto.



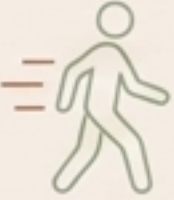
Retorno al Running: La Regla de las 12 Semanas

El impacto exige paciencia y preparación biomecánica.



Checklist de Diagnóstico: ¿Estás lista para el impacto?

Supera estas pruebas sin dolor, pérdidas, ni pesadez vaginal antes de tu primera carrera.

Test de Carga (Tolerancia al Impacto)	Test de Fuerza (Resistencia Muscular)
☐  Caminar rápido 30 minutos	☐  Elevación de talón a una pierna (20 reps)
☐  Trote estático (1 minuto)	☐  Puente de glúteo a una pierna (20 reps)
☐  Saltos hacia adelante (10 repeticiones)	☐  Sentadilla a una pierna (20 reps)
☐  Saltos a una sola pierna (10 reps por pierna)	☐  Abducción de cadera tumbada (20 reps)

Requisito: Cero dolor, pérdidas o pesadez

Banderas Rojas y Combustible Materno

Escucha a tu cuerpo. Retrocede si experimentas estas señales.



Sangrado
(reaparición de loquios post-esfuerzo).



Incontinencia
(fugas al saltar o correr).



Pesadez pélvica
(sensación de arrastre/bulto).



Dolor articular o lumbar agudo.

El Síndrome RED-S (Deficiencia Energética Relativa en el Deporte)

La lactancia materna exige un alto gasto calórico. Si combinas la lactancia con el ejercicio sin aumentar tu ingesta nutricional, corres el riesgo de sufrir pérdida de masa ósea, fatiga crónica y supresión metabólica. ¡La nutrición es tu armadura!

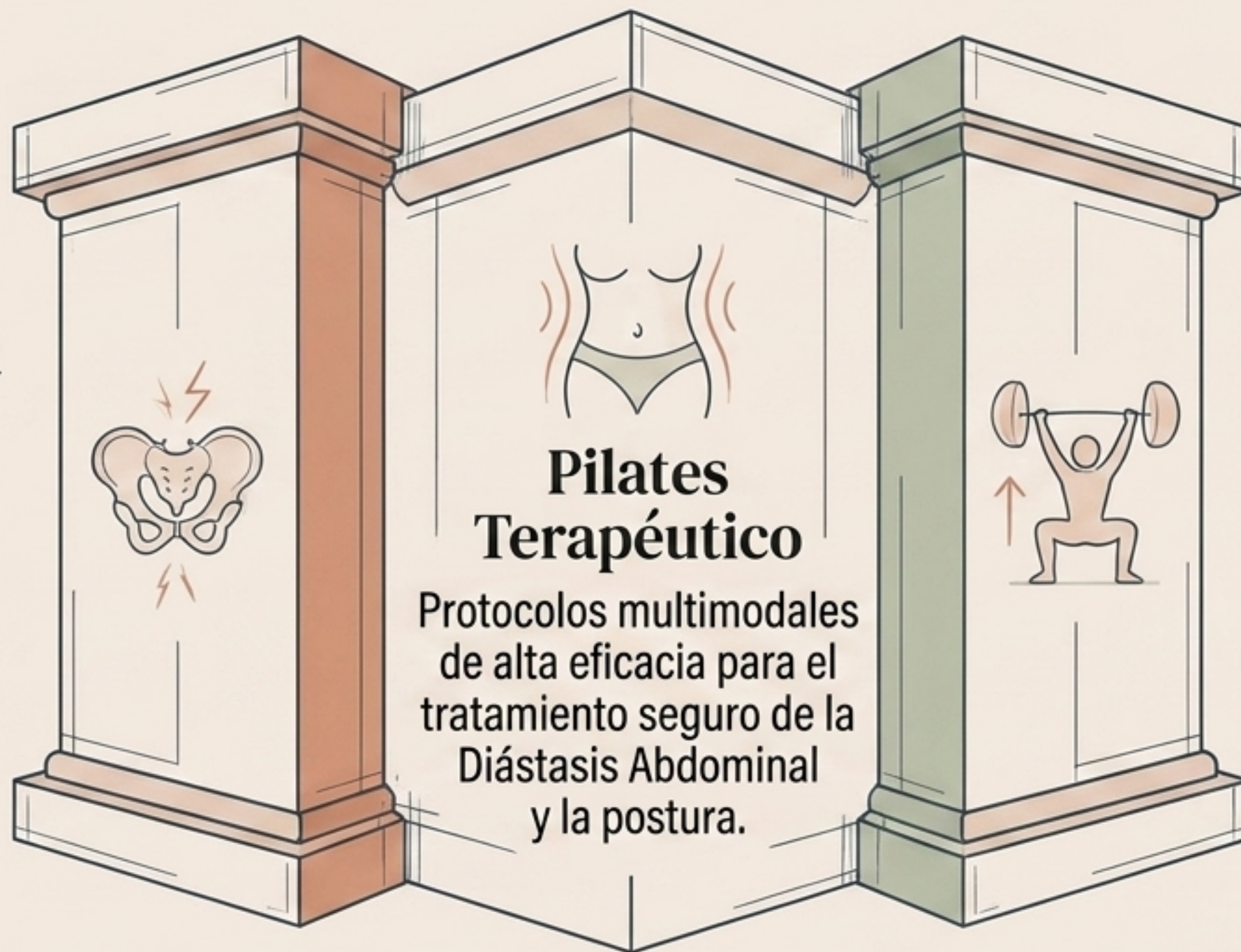
El Método Lumen: Tu Puente hacia la Fuerza

Integramos la evidencia científica 2025 en un entrenamiento diseñado exclusivamente para la anatomía femenina.



Conciencia Pélvica

Evaluación inicial, reeducación del suelo pélvico y prevención de disfunciones.



Pilates Terapéutico

Protocolos multimodales de alta eficacia para el tratamiento seguro de la Diástasis Abdominal y la postura.



Fuerza Funcional

Entrenamiento de resistencia adaptado. Desde levantar el cochecito hasta preparar tu cuerpo para el running o el envejecimiento activo.

Tu cuerpo creó vida. Ahora, vamos a darle fuerza.

Da el primer paso hacia una recuperación consciente y guiada por expertos.



lumenmovimiento.es

Descubre nuestros programas personalizados de entrenamiento físico para el posparto, Pilates y fuerza. Agenda tu valoración hoy.